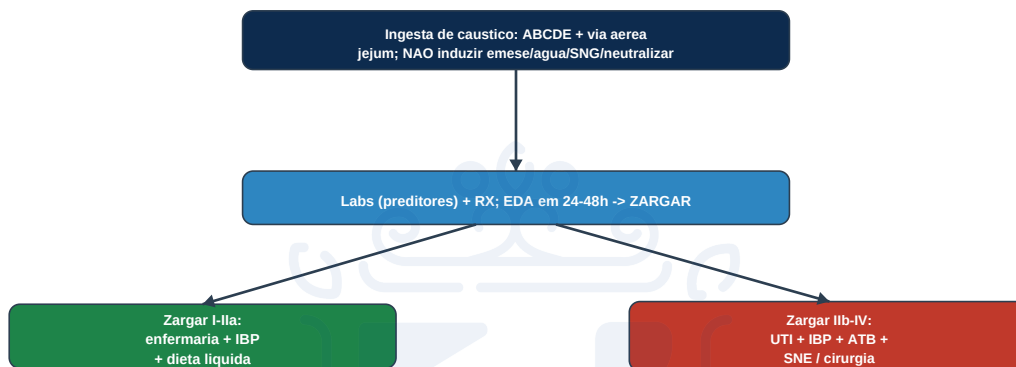


LESÃO CÁUSTICA — ZARGAR + EDA 24-48h

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

CÁUSTICO — NÃO NEUTRALIZAR -> EDA -> ZARGAR



ÁLCALI x ÁCIDO

Agente	Características
Alcalino (soda cáustica)	Necrose por LIQUEFAÇÃO; lesões mais proximais e profundas (maior dano de mucosa); ex.: 'diabo verde', limpeza pesada
Ácido (ác. de bateria)	Necrose por COAGULAÇÃO; lesões mais distais e menos profundas (escara limita o dano)

FASES E CLÍNICA

EVOLUÇÃO

- Fase AGUDA (primeiros ~10 dias): edema e inflamação
- Fase TRAIÇOEIRA (4-8 semanas): cura aparente, redução do processo inflamatório
- Fase de ESTENOSE cicatricial: disfagia progressiva
- Clínica: epigastria, dor torácica, dispneia, vômito/hematêmese, sibilos, rouquidão/estridor, disfagia/odinofagia, sialorreia
- Sintomas respiratórios (estridor/rouquidão) indicam acometimento de via aérea

MANEJO INICIAL — O QUE NÃO FAZER

REGRAS DE OURO

- Definir substância, quantidade e tempo desde a ingestão; jejum; ABCDE com proteção de via aérea
- NÃO induzir vômito; NÃO oferecer água/leite; NÃO passar SNG às cegas; NÃO tentar neutralizar (reação exotérmica piora a lesão)
- Labs: hemograma, PCR, eletrólitos, TGO/TGP, gasometria; preditores de lesão grave: pH < 7,2, BE -12, transaminases elevadas, trombocitopenia
- RX de tórax/abdome (pneumomediastino, pneumoperitônio); TC tem maior sensibilidade
- EDA em 24-48h para classificar (Zargar) — janela ideal; após 48h aumenta o risco de perfuração ao exame

CLASSIFICAÇÃO DE ZARGAR (EDA) E MANEJO

Grau	Achado -> conduta
I	Edema/eritema -> enfermaria 24h + IBP dose plena + dieta líquida
IIa	Friabilidade, erosões, exsudato -> enfermaria 24-48h + IBP + dieta líquida
IIb	+ ulcerações profundas -> UTI + IBP + dieta via SNE + ATB
IIIa/IIIb	Necrose (acinzentada/enegrecida) / extensa -> UTI + IBP + SNE + ATB + considerar cirurgia
IV	Perfuração esofágica -> UTI + IBP + ATB + abordagem CIRÚRGICA

PRESCRIÇÃO

Rx IBP ± CORTICOIDE

IBP: Pantoprazol 80 mg EV 12/12h por 48h, depois 40 mg EV 12/12h

Corticoide se acometimento de via aérea: Dexametasona 1 mg/kg/dia EV pela manhã por 3 dias (máx 24 mg/dia) ou Prednisolona 2 mg/kg/dia EV pela manhã por 3 dias (máx 60 mg/dia)

ATB nos graus IIb-IV (translocação/necrose); suporte nutricional via SNE nos graus avançados

Acompanhamento para estenose tardia (dilatações); risco aumentado de CEC de esôfago a longo prazo

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; ingestão de cáustico ____ (álcali/ácido), quantidade ____, há ____; intencional? ____.
- Via aérea ____ (estridor/rouquidão?); preditores graves (pH < 7,2, BE, transaminases, plaquetas): ____.
- Conduta: jejum, NÃO neutralizar, IBP EV ____, corticoide (se VA) ____, ATB ____; EDA (Zargar) ____.
- Solicito UTI + cirurgia se Zargar IIb-IV/perfuração; transporte com via aérea protegida.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual conduta está CONTRAINDICADA na ingestão de cáustico?

- A) Jejum
- B) Induzir êmese, oferecer água/leite ou tentar neutralizar a substância
- C) ABCDE com proteção de via aérea
- D) Solicitar EDA em 24-48h
- E) IBP endovenoso

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual o tipo de necrose causado por substâncias ALCALINAS?

- A) Necrose por coagulação
- B) Necrose por liquefação (lesões mais profundas)
- C) Necrose caseosa
- D) Necrose gordurosa
- E) Sem necrose

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o exame fundamental para classificar a gravidade da lesão cáustica, e em que janela?

- A) Colonoscopia imediata
- B) EDA em 24-48h (classificação de Zargar)
- C) Manometria
- D) pHmetria após 1 semana
- E) Esofagografia baritada precoce

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Lesão cáustica Zargar IV (perfuração esofágica). Qual a conduta?

- A) Alta com IBP oral
- B) UTI + IBP + antibiótico + abordagem cirúrgica
- C) Apenas dieta líquida
- D) Observação ambulatorial
- E) Corticoide isolado

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual complicação tardia é característica da lesão cáustica esofágica?

- A) Acalásia
- B) Estenose cicatricial com disfagia progressiva (e risco aumentado de CEC)
- C) Hérnia de hiato
- D) Divertículo de Zenker
- E) Refluxo alcalino isolado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

É contraindicado induzir êmese, oferecer água/leite ou tentar neutralizar a substância (reação exotérmica que agrava a lesão), bem como passar SNG às cegas. Mantém-se jejum, ABCDE e EDA precoce.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os álcalis causam necrose por liquefação, com lesões mais proximais e profundas; os ácidos causam necrose por coagulação, mais distais e superficiais (a escara limita o dano).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A EDA em 24-48h é fundamental e classifica a gravidade (Zargar). Após 48h o exame tem maior risco de perfuração; muito precocemente pode subestimar a lesão.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Zargar IV (perfuração esofágica) exige UTI, IBP, antibiótico e abordagem cirúrgica, dada a gravidade e o risco de mediastinite/sepsis.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A complicação tardia característica é a estenose cicatricial com disfagia progressiva (fase de estenose), além de risco aumentado de carcinoma espinocelular esofágico a longo prazo.

SM24
Suporte ao Plantão Médico